

Agitación psicomotora y contención

1. Introducción y relevancia clínica

La **agitación psicomotora** constituye una de las **emergencias psiquiátricas más frecuentes** y de mayor riesgo tanto para el paciente como para el equipo de salud.

Se caracteriza por un **estado de hiperactividad motora y emocional**, acompañado de **inquietud, impulsividad, irritabilidad o agresividad**, que puede escalar hacia conductas violentas o autoagresivas.

Relevancia clínica

- Hasta el **10% de las consultas psiquiátricas de urgencia** involucran pacientes agitados.
- Puede presentarse en el contexto de **trastornos psicóticos, maníacos, intoxicaciones, abstinencia o delirium**.
- El abordaje adecuado **previene lesiones, uso excesivo de fuerza y complicaciones médicas**.
- Es una **competencia obligatoria del médico general y del EUNACOM**, evaluada frecuentemente en casos clínicos y ECOE.

□ La prioridad inicial es **proteger la vida del paciente y del equipo**, controlando la conducta sin vulnerar derechos humanos.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La **agitación psicomotora** es un **síntoma inespecífico**, expresión de una **disregulación de los sistemas neurobiológicos de la emoción y del control motor**.

2.1. Mecanismos neurobiológicos implicados

- **Disfunción del sistema límbico (amígdala, hipocampo):** hiperrespuesta emocional.
- **Hiperactividad dopaminérgica mesolímbica:** explica los cuadros psicóticos y maníacos.

- **Disminución serotoninérgica:** reduce el control inhibitorio e incrementa impulsividad.
 - **Alteraciones GABAérgicas:** predisponen a agitación por abstinencia de alcohol o benzodiacepinas.
-

2.2. Principales etiologías (agrupadas por tipo de causa)

Grupo etiológico	Ejemplos clínicos
Psiquiátrico	Esquizofrenia aguda, manía, trastorno esquizoafectivo, depresión con agitación, trastorno de personalidad antisocial.
Tóxico o metabólico	Intoxicación por cocaína, anfetaminas, alcohol; abstinencia de benzodiacepinas o etanol; hipoglicemia, hipoxia.
Neurológico	Delirium, demencia, TCE, encefalitis, convulsiones parciales complejas.
Situacional o reactivo	Estrés agudo, crisis de pánico, violencia intrafamiliar.

☐ En mayores de 60 años, siempre descartar **delirium, hipoxia, infección o causas metabólicas** antes de asumir etiología psiquiátrica.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones clínicas

- **Inquietud motora:** caminar sin rumbo, gesticular, moverse en exceso.
- **Tensión emocional:** irritabilidad, impaciencia, ansiedad o miedo.
- **Conductas disruptivas:** gritos, insultos, amenazas, destrucción de objetos.

- **Agresividad física:** hacia otros o hacia sí mismo.
- **Trastornos del pensamiento:** incoherencia, delirios, alucinaciones.
- **Autopercepción alterada:** desorientación o falta de juicio.

La severidad varía desde una leve inquietud hasta un estado de **furor psicomotor** (violencia extrema).

3.2. Niveles de agitación

Nivel	Características	Manejo prioritario
Leve	Inquietud, tensión verbal, ansiedad.	Intervención verbal, ambiente seguro.
Moderada	Aumento de volumen de voz, resistencia a indicaciones.	Intervención verbal + farmacológica oral.
Grave	Agresividad física, descontrol, riesgo vital.	Contención física + fármacos parenterales.

3.3. Diagnóstico diferencial

Condición	Claves diferenciales
Delirium	Inicio agudo, fluctuante, alteración de conciencia, causas médicas.
Episodio maníaco	Expansividad, logorrea, disminución de necesidad de sueño.

Esquizofrenia aguda	Alucinaciones, delirios, conducta desorganizada.
Intoxicación por estimulantes	Midriasis, taquicardia, euforia, paranoia.
Abstinencia alcohólica	Temblor, sudoración, taquicardia, alucinaciones visuales.
Trastorno de personalidad	Agitación situacional, con manipulación o dramatización.

☐ Siempre evaluar signos vitales y glucemia capilar antes de atribuir causa psiquiátrica.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Evaluación inicial (ABCDE psiquiátrico)

1. **A – Airway:** vía aérea permeable.
 2. **B – Breathing:** evaluar frecuencia y saturación.
 3. **C – Circulation:** presión arterial, pulso, temperatura.
 4. **D – Disability:** nivel de conciencia (Glasgow), signos neurológicos.
 5. **E – Environment:** retirar objetos peligrosos y asegurar entorno.
-

4.2. Exámenes básicos recomendados

- **Glicemia capilar inmediata.**
- **Tóxicos en orina:** cocaína, anfetaminas, cannabis, benzodiacepinas.
- **Electrolitos, creatinina, función hepática.**
- **Hemograma y PCR:** descartar infección o anemia.
- **ECG:** previo a uso de antipsicóticos (riesgo de QT largo).

- **Neuroimagen (TAC cerebral):** si hay focalidad, trauma o debut atípico.
-

4.3. Diagnóstico clínico

El diagnóstico de **agitación psicomotora** se establece cuando existe:

1. **Actividad motora aumentada o desorganizada.**
2. **Inquietud emocional o irritabilidad significativa.**
3. **Interferencia funcional o riesgo de daño.**

No requiere exámenes específicos, pero **sí identificación de causa subyacente.**

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo debe seguir un **enfoque escalonado**:

1. Intervención ambiental.
 2. Contención verbal.
 3. Contención farmacológica.
 4. Contención física (solo si es imprescindible).
-

5.1. Intervención ambiental

- Mantener **ambiente tranquilo, seguro y sin estímulos excesivos.**
- Presencia de personal suficiente (mínimo 4 personas entrenadas).
- Retirar objetos peligrosos.
- Mantener **salida despejada** para el personal.
- Informar al paciente en todo momento lo que se está haciendo.

5.2. Contención verbal (primera línea)

Objetivo: **reducir tensión sin medicación ni fuerza física.**

- Escucha activa y tono de voz calmado.
- No confrontar ni amenazar.
- Validar emociones: “Entiendo que está molesto, pero queremos ayudarlo.”
- Ofrecer alternativas: “¿Prefiere conversar aquí o en una sala más tranquila?”
- Mantener **distancia segura (1,5–2 metros)**.

☐ La empatía y la comunicación clara pueden evitar la contención física en hasta **70% de los casos**.

5.3. Contención farmacológica

Se usa cuando las medidas verbales son insuficientes o hay riesgo de daño.

A. Vía oral (si cooperativo)

Situación	Fármaco	Dosis inicial	Comentarios
Agitación psicótica	Risperidona	1–2 mg VO	Puede combinarse con lorazepam.
Agitación ansiosa o reactiva	Lorazepam	1–2 mg VO	Evitar en intoxicación alcohólica.
Manía o esquizofrenia	Olanzapina	5–10 mg VO	Eficaz y bien tolerada.

B. Vía intramuscular (si no cooperativo o riesgo alto)

Situación	Fármaco	Dosis IM	Comentarios
Agitación psicótica grave	Haloperidol 5 mg + Biperideno 2 mg	Repetir cada 30–60 min si necesario (máx 20 mg/24 h).	
Alternativa	Olanzapina IM 10 mg	No combinar con benzodiacepinas IM.	
Agitación ansiosa sin psicosis	Lorazepam IM 1–2 mg	Controlar vía aérea y sedación.	
Delirium o demencia	Haloperidol 0,5–2 mg IM	Evitar benzodiacepinas salvo abstinencia alcohólica.	
☐ Nunca usar haloperidol sin biperideno (previene distonías agudas). ☐ Evitar mezcla de olanzapina IM y benzodiacepina : riesgo de depresión respiratoria.			

5.4. Contención física

Se reserva para:

- Riesgo inminente de auto o heteroagresión.
- Fracaso de medidas verbales y farmacológicas.

Principios éticos y técnicos

- Requiere **orden médica documentada**.
- Debe realizarse por **mínimo 4 personas entrenadas**.
- Utilizar **sujeción mecánica blanda** (muñecas, tobillos, tronco).
- Controlar signos vitales cada 15 minutos.
- Liberar progresivamente una vez controlada la agitación.

- Mantener **registro clínico y notificación legal** (Ley 21.331 de Derechos en Salud Mental, Chile).
-

5.5. Evaluación posterior

- Reevaluar diagnóstico etiológico una vez estabilizado.
 - Controlar efectos adversos: distonías, hipotensión, depresión respiratoria.
 - Iniciar tratamiento específico según causa (p. ej., antipsicóticos de mantención, manejo del alcoholismo).
 - Derivar a hospitalización psiquiátrica si:
 - Riesgo suicida u homicida.
 - Psicosis aguda.
 - Falta de red de apoyo o autocuidado.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones posibles

- Lesiones musculares o asfixia por contención física inadecuada.
- Reacciones distónicas, acatisia, síndrome neuroléptico maligno.
- Hipotensión, depresión respiratoria (benzodiacepinas).
- Daño psicológico por contención coercitiva.
- Cronificación del trastorno si no se aborda la causa.

Pronóstico

- Con intervención oportuna y empática, la mayoría de los casos se estabiliza en horas.

- El pronóstico depende de la **causa subyacente**:
 - **Psicosis o manía**: buen pronóstico con adherencia terapéutica.
 - **Delirium**: mortalidad elevada si no se trata la causa médica.
 - **Abstinencia o intoxicación**: resolución al eliminar el tóxico.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. La agitación psicomotora **es un síntoma, no un diagnóstico**: siempre buscar la causa.
 2. En mayores, **delirium metabólico o infeccioso** es más frecuente que esquizofrenia.
 3. El manejo debe comenzar con **contención verbal y ambiental**.
 4. **Haloperidol + biperideno IM** sigue siendo la combinación más segura en urgencias psiquiátricas.
 5. En intoxicación alcohólica o abstinencia, **prefiera benzodiazepinas**.
 6. Evite combinar **olanzapina IM con benzodiazepinas**.
 7. Todo procedimiento coercitivo debe ser **proporcional, documentado y revisado periódicamente**.
-



Errores comunes

- Omitir examen físico o glicemia antes de medicar.
- Usar benzodiazepinas en delirium no alcohólico.

- Aplicar contención física sin justificación escrita.
 - No acompañar haloperidol con biperideno.
 - Administrar múltiples fármacos simultáneamente sin control de efectos.
 - No reevaluar al paciente tras la sedación.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **agitación psicomotora** es una emergencia psiquiátrica de alto riesgo; siempre se debe **buscar la causa médica o psiquiátrica subyacente**.
2. El manejo es **escalonado**: ambiente seguro → contención verbal → farmacológica → física.
3. La combinación **haloperidol + biperideno IM** es el estándar seguro en agitación grave.
4. En **abstinencia alcohólica**, usar **benzodiacepinas** (diazepam o lorazepam).
5. La **contención física** solo se indica en riesgo inminente, con **registro y supervisión médica**.
6. La **empatía y comunicación calmada** reducen significativamente la necesidad de coerción.
7. Una vez controlada la crisis, siempre reevaluar diagnóstico y derivar para seguimiento psiquiátrico.